

DOCTEUR

Robert Lucchese

, PSYCHIATRE



Portland,

2548, Northwest Thurman Street

COMPTE RENDU, ANNÉE 2022

PATIENT : SAM RAWLINS, 26 ANS.

L'individu a été présenté au cabinet suite à la demande du Portland Police Departement, après multiples interpellations en état d'ébriété sur la voie publique.

Le patient se présente en état de grande désorganisation psychique.

Il minimise sa consommation d'alcool, tout en reconnaissant des pertes de contrôle fréquentes.

Présence évidente d'un PTSD, non traité depuis plusieurs années. Cauchemars récurrents, flashbacks, hypervigilance constante, sursauts au bruit.

Sam verbalise peu ses émotions. Il décrit son vécu de manière mécanique, presque clinique, comme s'il parlait d'un autre que lui-même.

Fort sentiment de culpabilité lié à un tir en opération ayant entraîné la mort d'un civil.

Le nom de  revient de manière obsessionnelle.

Figure idéalisée, presque paternelle.

Ambivalence marquée : admiration intacte pour l'homme qu'il était, colère sourde contre l'officier qui a donné l'ordre de tir.

Sam oscille entre la loyauté aveugle et un ressentiment qu'il n'assume pas.

On note une tendance à l'auto-punition par l'alcool et la prise anarchique de médicaments. Le patient exprime l'idée qu'il "mérite" cet état.

Isolement social quasi total. Perte de repères identitaires depuis sa réforme de l'armée.

Objectif initial : stabilisation, réduction de la consommation, mise en place d'un cadre de sécurité minimal.

Pronostic réservé. Patient peu confiant dans l'intérêt de la thérapie.



COMPTE RENDU, ANNÉE 2023

PATIENT : SAM RAWLINS, 27 ANS.

Le patient montre une légère amélioration dans l'adhésion au suivi.

Diminution des épisodes d'ivresse aiguë, bien que la consommation d'alcool reste problématique.

Premières tentatives de verbalisation émotionnelle, encore limitées par des mécanismes d'évitement.

Le PTSD demeure actif, avec une symptomatologie intrusive persistante.

Toutefois, Sam commence à identifier certains déclencheurs sensoriels et contextuels.

Évolution notable dans le rapport à [REDACTED] : le patient verbalise pour la première fois une colère assumée envers son ancien chef de section.

Cette colère coexiste avec une admiration intacte, générant un conflit interne.

Le patient reconnaît que son attachement à [REDACTED] relève en partie d'un besoin de figure d'autorité stable.

Il commence à entrevoir que la chute de son mentor a contribué à sa propre désorganisation psychique.

L'alcool est identifié comme un moyen d'auto-anesthésie face aux souvenirs traumatiques.

Sam formule l'idée que boire lui permet de "faire taire les voix du passé", notamment celle de [REDACTED]

Les premiers outils de régulation émotionnelle sont intégrés de manière inégale.

Projection émergente vers un futur hors de l'armée, sans représentation claire du rôle qu'il pourrait y tenir.

Pronostic modérément favorable sous condition de maintien du suivi.



COMPTE RENDU, ANNÉE 2024

PATIENT : SAM RAWLINS, 28 ANS.

Amélioration globale du fonctionnement psychique.

Les symptômes de PTSD sont moins présents, et le patient commence à développer des stratégies de gestion plus efficaces.

Diminution de la fréquence et de l'intensité des crises de panique. Meilleure tolérance aux environnements stressants.

La consommation d'alcool est en nette régression.

Alternance de périodes d'abstinence et de rechutes ponctuelles.

Le patient verbalise désormais la dépendance comme une problématique centrale, et non plus comme un "effet secondaire" de sa souffrance.

Le discours sur [REDACTED] gagne en nuance.

Sam parvient à penser son mentor comme un individu faillible, pris dans une chaîne de décisions opérationnelles. L'idéalisation se fissure sans s'effondrer.

Le patient exprime une colère plus structurée : non plus uniquement contre [REDACTED] mais contre le système, la hiérarchie, et contre lui-même pour sa soumission aveugle à l'époque.

Premières évocations concrètes d'un désir de retrouver un cadre structurant proche de celui de l'armée, mais dans un contexte civil.

Le patient mentionne l'idée de servir à nouveau, cette fois dans un cadre légal intérieur, avec un rapport différent à l'autorité et à la responsabilité.

Cette émergence est interprétée comme une tentative de reconstruction identitaire.

Pronostic favorable si poursuite de l'abstinence progressive et maintien du travail sur le trauma.



PATIENT : SAM RAWLINS, 29 ANS.

Évolution très positive. Le patient est engagé dans une démarche de sobriété durable. Absence de consommation d'alcool sur les derniers mois de l'année. Les stratégies de régulation émotionnelle sont intégrées et utilisées de manière autonome.

Le PTSD reste présent en fond, mais complètement gérable : les symptômes n'entravent plus de manière significative son quotidien.

Sam est capable d'anticiper ses déclencheurs, lui permettant de gérer une situation stressante et de verbaliser ses états internes.

Transformation majeure du rapport à  :
L'ambivalence est pleinement intégrée : Sam peut simultanément admirer l'homme qu'il a été et reconnaître la colère liée à l'abandon ressenti après sa radiation.

Cette intégration permet une diminution nette de la culpabilité projetée.
Le patient commence à se pardonner partiellement d'avoir obéi à un ordre dans un contexte de guerre.

Reconstruction identitaire avancée. Le patient se projette concrètement dans une réintégration d'un cadre de service et d'ordre public.

Il exprime le souhait de rejoindre une institution civile lui permettant de mettre ses compétences au service de la protection des civils, en réparation symbolique de l'événement traumatique initial.

Motivation cohérente, discours stable, absence de glorification de la violence.

Pronostic très favorable : le départ temporaire sur San Andreas est recommandé comme étape de transition avant intégration professionnelle, afin de consolider les acquis psychiques et tester sa stabilité dans un environnement nouveau.



